

KC桌面——外资精译

波士顿咨询：AI重塑患者接入中心，自动化可承接超半数来电

美国医疗系统每年有高达40%的预约相关互动在首次接触时未能解决，数千通电话因等待时间过长、转接失败或非工作时间覆盖不足而被放弃或无人接听。波士顿咨询最新报告指出，患者接入中心既是医疗系统面向患者的“前门”，也是其运营的“心脏”，但多数高管仅将AI视为降本增效的工具，忽略了其重塑整个接入功能、将其从成本中心转变为收入引擎的潜力。

Option	Advantages	Disadvantages
Buy capability from vendor	• Faster initial implementation, especially for initial use cases • Ongoing vendor R&D to improve product and capability • Less need to develop scaled engineering and delivery function to build, maintain, and evolve solution • Lower upfront capital requirement	• Potential for vendor lock-in, which is risky given pace of change with AI capabilities • More limited ability to integrate with custom business logic, given use of standard integration patterns • Less ability to customize style, tone, experience • Potential for higher total cost of ownership and run-rate expense, given per-interaction pricing model
Build internal capability	• Ability to fully accommodate custom business logic • Ownership of orchestration layer, coordinating agent activity and preserving optionality • Ability to develop differentiated capability that fully reflects the health system • Potential for lower total cost of ownership, given consumption-oriented cost	• Longer time to initial release • Need for sustained internal engineering capability to build, maintain, and develop future features • Ongoing oversight, including model drift, prompt updates, business logic changes, etc. • Higher upfront capital investment

图表 1

自动化常规流程可承接超半数来电，但需谨慎选择构建路径

报告识别出三类高自动化潜力的互动：预约信息确认、预约安排与取消、转诊与授权状态查询及常规问询。这些互动频率高、流程标准化、有清晰的解决路径且不涉及临床判断，在大型医疗系统中通常占来电总量的50%以上。AI可独立处理这些互动，无需人工介入。然而，目前尚无单一供应商能提供完整的端到端虚拟代理解决方案，医疗系统需在购买现成产品（如Hyro、Sierra、Decagon、Avaamo等）与自建之间做出选择。这一决策需权衡速度、长期灵活性、与定制业务逻辑的整合能力、总拥有成本及未来token成本等不确定变量。

> KC评论：对医疗系统而言，AI部署不是单纯的技术选型，而是对自身业务逻辑成熟度的一次不确定性测试。那些预约规则、保险验证逻辑仍依赖Excel表格或员工口口相传的系统，即便引入最先进的AI工具，也难以实现可靠自动化。

人机协作可缩短30%-40%通话时长，但需先解决60%的低效时间

报告估计，短期内仍有40%-50%的来电需要人工介入，原因包括预约复杂性、转诊协调、敏感话题或患者偏好。在这些场景中，AI应作为“代理助手”发挥作用。数据显示，目前人工代理多达60%的时间花在可被AI增强的任务上，如身份验证、患者信息检索、通话指引及事后总结。部署AI助手后，平均通话处理时间可缩短30%-40%，同时将代理从基础信息检索中解放出来，专注于共情倾听与创造性解决问题。AI还能自动生成通话摘要、收件箱消息及后续工单，每次互动可减少最多2分钟的事后工作。此外，AI驱动的质量评估能力可改变当前多数系统仅抽样不到5%互动进行人工审查的现状，实现近乎全覆盖的实时质量监控与个性化培训。

融入增长策略可使利润提升幅度扩大3-5倍，但70%的挑战在技术与运营之外

报告强调，若仅聚焦成本削减，AI优化的利润提升空间有限；而将增长策略纳入路线图，可使预计利润提升幅度扩大3-5倍。具体增长杠杆包括：AI驱动的24/7全覆盖与未接来电自动跟进以捕获流失需求；在每次互动中实时提到影像、检验、药房及预防性护理机会；追踪转诊状态并触发跟进以减少网络内患者流失；针对已知护理缺口、逾期筛查或出院后需求的患者进行主动外呼。然而，技术仅占AI转型的约30%，人员与变革管理占70%。许多医疗系统的预约规则、排班限制、就诊类型配置及医生层级指令既非集中管理，也未形成标准化文档。系统必须将分散在人工代理、医疗助理和医生手中的正式与非正式业务逻辑，转化为AI可消费的结构化输入。扩展代理预约权限、改善诊所与接入中心的响应关系、规范模板与就诊类型映射、完善保险规则文档，这些运营层面的变革是AI成功的前提。